

ВИНЬЕТКИ

Судороги

Пять вызовов: фебрильные, гипогликемические, абстинентные, эпилептический и постиктальное состояние с травмой головы

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Два года

Девочка, 2 года, вес около 12 кг. Три часа назад температура 39,2 °С. Пять минут назад — генерализованные тонико-клонические судороги, длились 2 минуты, сейчас спит. Впервые в жизни. Утром насморк, кашель. Прививки по графику.

Сопор: будят с трудом, плачет, снова засыпает. Температура 39,5 °С. ЧД 24 в минуту, SpO₂ 98 %, ЧСС 140 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. Кожа горячая, румянец.

Менингеальных знаков нет, очаговой неврологии нет.

1. Диагноз с обоснованием.
2. Это эпилепсия?
3. Оценка по шкале комы Глазго, детский вариант.
4. Действия по порядку.
5. Жаропонижающее: препарат, доза на 12 кг, путь.
6. Нужны ли противосудорожные, если судороги закончились?
7. Госпитализация: да или нет, куда, почему.
8. Что сказать матери про прогноз.

Случай 2. Не ел, выпил

Мужчина, 48 лет. Сахарный диабет 2-го типа: метформин 2000 мг в сутки и глимепирид 4 мг. Вчера 0,5 л водки, почти не ел. Утром не разбудили. При бригаде — генерализованные судороги уже 3 минуты. Кожа бледная, холодный липкий пот. ЧД около 10 в минуту. ЧСС 110 в минуту. Глюкоза 1,8 ммоль/л.

1. Диагноз. Почему гипогликемия у этого пациента?
2. Действия прямо сейчас.
3. Что вводится первым: препарат, доза, последовательность.
4. Зачем тиамин?
5. Судороги не прекратились через 2 минуты после глюкозы. Что дальше?
6. Глюкоза подействовала, сопор. Как профилактировать рецидив?
7. Куда везти?

Случай 3. Три дня без денег

Мужчина около 50 лет, пьёт каждый день. Три дня нет денег, не пьёт. Два дня — тремор, «разговаривал с кем-то». Соседка нашла после судорог.

После приступа: сопор, затем спутанность, ШКГ 12 (Е3 V4 M5). Тремор, пот, гиперемия лица. ЧД 22 в минуту, SpO₂ 96 %, ЧСС 120 в минуту, АД 160/100 мм рт. ст. Мидриаз, живая фотореакция. Глюкоза 4,2 ммоль/л. «Черти ползут.» Судороги впервые.

1. Диагноз: синдром, стадия, причина судорог.
2. Что происходит патофизиологически?
3. Риск повторных судорог?
4. Препараты для профилактики повторных судорог.
5. Доза диазепама.
6. Нужна ли магния сульфат?
7. Куда везти?
8. Можно ли оставить дома при отказе?

Случай 4. Восемнадцать минут

Женщина, 35 лет, эпилепсия 10 лет, карбамазепин. Три дня таблеток нет. Судороги дома 10 минут до вызова, бригада ехала 8 минут — судороги продолжаются. Цианоз. ЧД около 8 в минуту, SpO₂ 85 %, ЧСС 130 в минуту. Пена с кровью. Глюкоза 5,6 ммоль/л.

1. Это эпилептический статус? По какому критерию?
2. Действия в первые 30 секунд.
3. Препарат первой линии и доза.
4. Нужна ли интубация сейчас при SpO₂ 85 % и продолжающихся судорогах?
5. Через 5 минут после диазепама 20 мг судороги продолжаются. Что дальше?
6. Судороги прекратились после мидазолама 10 мг, суммарно 25 минут, ШКГ 6. Что делать?
7. Куда везти?

Случай 5. Удар головой в метро

Мужчина около 40 лет. В метро упал, судороги около 2 минут, ударился головой. Судороги прекратились 5 минут назад, храпит.

Сопор, ШКГ 10 (E2 V3 M5). Храпящее дыхание. ЧД 18 в минуту, SpO₂ 91 %, ЧСС 95 в минуту, АД 140/85 мм рт. ст. Зрачки равные. Ссадина темени 2×3 см, гематома затылка 4×5 см. Глюкоза 5,8 ммоль/л.

Через 10 минут: глаза открыты, не помнит, где находится. ШКГ 13 (E4 V4 M6). Говорит, что «известный эпилептик, приступы раз в месяц, всегда так, отпустите».

1. Что с пациентом?
2. Минимум три риска.
3. Действия, пока ШКГ была 10 и он храпел.
4. Нужна ли интубация при ШКГ 10?
5. Отпускать ли при ШКГ 13 и известной эпилепсии?
6. Показания к госпитализации в этом случае.
7. Куда везти?

Решения

Случай 1

1. Простые фебрильные судороги: возраст 6 месяцев — 5 лет, температура, генерализованный приступ меньше 15 минут, один за эпизод, впервые, очага нет.
2. Нет. Фебрильные судороги — не эпилепсия. Эпилепсия — повторные неспровоцированные приступы.
3. Будят с трудом, плачет, засыпает: ориентир E3 V3–4 M5, сумма около 11–12. Точная цифра меньше важна, чем то, что это постиктальный сон, а не кома.
4. Дыхательные пути, кислород по сатурации, глюкоза, температура, осмотр на очаг и сыпь, жаропонижающее, эвакуация. Противосудорожный препарат, если приступ идёт.
5. Парацетамол 15 мг/кг: 180 мг ректально или внутрь, если глотает. Ибупрофен 10 мг/кг — альтернатива при отсутствии противопоказаний.
6. Нет. Приступ закончился. Профилактический бензодиазепин после простого фебрильного приступа не показан.
7. Да. Первый эпизод — стационар, педиатрия или инфекционное по маршруту, исключить менингит и другую причину. Дома не оставляют.
8. Приступ связан с температурой, обычно не повторяется в этот же час, это не приговор эпилепсии. Повтор при новой лихорадке возможен. Если приступ дольше 5 минут, повторяется или появляется сыпь — вызов снова.

Случай 2

1. Гипогликемические судороги. Глимепирид — сульфонилмочевина, стимулирует инсулин; алкоголь без еды закрывает глюконеогенез в печени.
2. Защита дыхательных путей, кислород, доступ. Судороги на 1,8 ммоль/л не «ждут диазепам первым» — корень в глюкозе.
3. Первым — глюкоза 40 % внутривенно, 20–40 мл, до восстановления сознания или до нормы на глюкометре. Тиамин 100 мг внутривенно до или вместе с глюкозой: пациент пьёт. Если доступа нет — глюкагон внутримышечно, если есть в укладке.
4. Алкоголь и голодание истощают тиамин. Глюкоза без тиамина может спровоцировать острую энцефалопатию Вернике.
5. Мидазолам внутримышечно или диазепам внутривенно по алгоритму судорог. Глюкозу повторяют, если цифра ещё низкая. Корень и судорожный круг гасят вместе.
6. Повторный глюкометр. Еда или инфузия глюкозы 5–10 %: сульфонилмочевина держит инсулин часами. Не оставлять с «нормальной» одной цифрой.
7. Стационар, терапия или реанимация. Сульфонилмочевина даёт поздний рецидив.

Случай 3

1. Алкогольный абстинентный синдром, делирий, судорожный приступ отмены. Срок — двое-трое суток без алкоголя.
2. Хронический алкоголь усиливает торможение через GABA и глушит NMDA. Резкая отмена снимает тормоз: возбуждение, вегетатика, судороги, галлюцинации.
3. Высокий. Один абстинентный приступ предсказывает следующий. «Черти» — уже делирий, не «просто трясёт».
4. Бензодиазепин — первая линия. Тиамин. Глюкоза, если низкая (здесь 4,2 — на грани, повторить). Не галоперидол как первый препарат: снижает порог судорог.

5. Диазепам 10 мг внутривенно, повтор по эффекту. При возбуждении без доступа — мидазолам внутримышечно.
6. Не как противосудорожный препарат первой линии. Показана при гипомагнемии, аритмии, тяжёлой абстиненции в стационаре. На линии не заменяет диазепам.
7. Реанимация или токсикология / психиатрия с реанимационной готовностью. Делирий с судорогами дома не лечится.
8. Нет. Отказ при делирии не является информированным. Оформление отказа не отменяет повторный вызов и актив.

Случай 4

1. Да. Генерализованные судороги дольше 5 минут — эпилептический статус. Здесь 18 минут.
2. Дыхательные пути, кислород, положение, глюкоза (уже 5,6 — не она), доступ. Не ждать «само пройдёт».
3. Диазепам 10 мг внутривенно, повтор до 20 мг, или мидазолам 10 мг внутримышечно, если доступа нет. «Нет вены на судорогах — мидазолам внутримышечно. Для этого он и существует.»
4. Сначала бензодиазепин и кислород. Интубация на судорогах без седации и релаксации хуже, чем после купирования. Если после препарата сатурация не растёт и сознание не возвращается — тогда дыхательные пути жёстко.
5. Вторая доза бензодиазепа, если суммарно ещё не потолок. Дальше — вторая линия уже в стационаре (вальпроат, леветирацетам, фосфонитоин — по протоколу приёмника). На линии не вводят третий класс «на глаз».
6. ШКГ 6 после статуса — кома. Дыхательные пути, вентиляция, мониторинг, эвакуация в реанимацию. Постиктальная кома и отёк мозга не разбираются на кухне.
7. Реанимация многопрофильного стационара, не «неврология планово».

Случай 5

1. Постиктальное состояние после генерализованного приступа плюс закрытая черепно-мозговая травма: удар головой, две гематомы скальпа.
2. Аспирация и западение языка. Внутрочерепная гематома, которая проявится не сразу. Повторный приступ. Пропущенная гипогликемия (здесь уже исключена). Шейная травма при падении.
3. Тройной приём или воздуховод, кислород, боковое устойчивое, глюкоза, осмотр зрачков и скальпа, шейный воротник при механизме, мониторинг.
4. Нет автоматически. ШКГ 10 при храпе и постикте часто ведётся воздуховодом и кислородом. Интубация — если после восстановления проходимости сатурация не растёт, сознание падает, или рвота не управляется.
5. Нет. «Всегда так» не отменяет удар головой и амнезию. Отказ после приступа с травмой головы не принимается как спокойный отказ известного эпилептика без травмы.
6. Первый приступ на глазах свидетелей с травмой головы. Амнезия. Гематома скальпа. Храп и ШКГ 10 на осмотре. Даже известная эпилепсия плюс удар — госпитализация.
7. Приёмник с возможностью КТ: травма или неврология многопрофильного стационара, не «домой под расписку».

Основные выводы

№	Вывод
1	Фебрильные судороги — не эпилепсия. Первый эпизод госпитализируют. Противосудорожный после остановки приступа не нужен.
2	Судороги плюс 1,8 ммоль/л — сначала глюкоза. Тиамин до глюкозы, если пациент пьёт.
3	Трое суток без алкоголя плюс «черти» — делирий. Первый препарат — диазепам, не галоперидол.
4	Дольше 5 минут — статус. Нет вены — мидазолам внутримышечно.
5	Постикт плюс удар головой — не «обычный приступ». Домой не отпускают.